GGPSYKOLOG AS — TESTBASE

Vurdering av risikoklasse for TestBase sin skåringsfunksjonalitet under forordning (EU) 2017/745 (MDR)

Klassifiseringsvurdering etter MDR vedlegg VIII, regel 11 — produsentens egen begrunnede vurdering

Produkt	TestBase — online testsystem for psykologiske selvrapporteringstester
Produsent	GGPsykolog AS
Dokumenttype	Intern klassifiseringsvurdering (produsentens eget ansvar, jf. MDR art. 4 og 51)
Dato	17. oktober 2026
Versjon	1.0
Status	Utkast — til kvalitetssikring før bruk i teknisk dokumentasjonsfil

---

Dette dokumentet er produsentens egen rettslige drøftelse og dokumentasjon av risikoklassifisering, utarbeidet fordi Direktoratet for medisinske produkter (DMP) — som tilsynsmyndighet uten godkjenningsrolle — eksplisitt har presisert at kvalifisering og klassifisering er produsentens eget ansvar (DMP, e-post 15.10.2026). Dokumentet er ikke kvalitetssikret av meldt organ eller ekstern regulatorisk rådgiver, og skal behandles som et utkast frem til slik kvalitetssikring er gjennomført.

1. Innledning og formål

Dette dokumentet drøfter og dokumenterer hvilken risikoklasse TestBase sin automatiske skåringsfunksjon for psykologiske selvrapporteringstester skal tilordnes under forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr («MDR»), gitt at funksjonen allerede er lagt til grunn å kvalifisere som programvare som medisinsk utstyr («Medical Device Software», MDSW) — se punkt 3.1.

Metodikken følger den fremgangsmåten EU selv anviser for produsenter: sammenligning av TestBase sitt tiltenkte formål og faktiske funksjonalitet mot (i) ordlyden i klassifiseringsregel 11 i MDR vedlegg VIII, og (ii) de offisielle, publiserte eksemplene på anvendelse av denne regelen i MDCG 2019-11 Rev.1 (juni 2025) og i MDCG sin «Manual on borderline and classification for medical devices» (versjon 5, april 2026). Begge er offentlige veiledningsdokumenter fra henholdsvis Medical Device Coordination Group og undergruppen Borderline and Classification Working Group, og er nettopp utformet for at produsenter skal kunne resonnere analogt fra deres eksempler til eget produkt.

Drøftelsen er strukturert slik at TestBase sin funksjonalitet vurderes opp mot hver av de tre aktuelle klassene under regel 11 — klasse III, klasse IIa og klasse IIb — med argumenter for og imot hver klasse, før en samlet konklusjon trekkes til slutt i punkt 4.4.

2. Produktbeskrivelse og tiltenkt formål

TestBase er et nettbasert system der en autorisert psykolog eller psykologspesialist tildeler standardiserte, publiserte psykologiske selvrapporteringsskjema til egne pasienter for digital utfylling. Ved fullført utfylling beregner systemet automatisk en pasientspesifikk skåre etter instrumentets offentliggjorte, etablerte skåringsalgoritme (f.eks. sumskåring, vekting og eventuell undersjekt-beregning slik den publiserte manualen for instrumentet foreskriver), og presenterer skåren sammen med instrumentets publiserte tolkningsintervaller/terskelverdier for behandler. Testbiblioteket omfatter per i dag blant annet instrumenter rettet mot traumesymptomer (eksempelvis ITQ) og depressive symptomer (eksempelvis et PHQ-9-aktig instrument), i tillegg til bredere mål på psykisk fungering — det vil si instrumenter som dekker forhold som generelt regnes som klinisk alvorlige psykiske tilstander, ikke utelukkende lavterskel velværemål.

Nedenfor foreslås en formulering av tiltenkt formål for skåringsfunksjonen, i tråd med MDCG 2019-11 Rev.1 sin presisering av at et presist og uttømmende formulert tiltenkt formål er avgjørende for korrekt kvalifisering og klassifisering (MDCG 2019-11 Rev.1, punkt 3). Formuleringen er et utkast fra denne vurderingen og bør endelig fastsettes av produsenten selv før den låses i teknisk dokumentasjon.

UTKAST TIL TILTENKT FORMÅL

«TestBase sin skåringsfunksjon er tiltenkt å støtte en autorisert psykolog eller psykologspesialist i vurderingen av en pasients symptomtrykk, alvorlighetsgrad og endring over tid, ved automatisk å beregne en pasientspesifikk skåre fra pasientens egne svar på standardiserte, publiserte selvrapporteringsskjema, i henhold til det enkelte instrumentets offentliggjorte skåringsalgoritme. Skåren, sammen med instrumentets publiserte tolkningsintervaller, presenteres til behandler som beslutningsstøtte i den kliniske oppfølgingen. Programvaren fastsetter ikke selv en diagnose og anbefaler ikke selv behandling — enhver klinisk tolkning, diagnostisk vurdering og

behandlingsbeslutning foretas selvstendig av den autoriserte behandleren, uavhengig av og i tillegg til den fremviste skåren.»

Denne formuleringen er bevisst ikke avgrenset til kun oppfølging under pågående behandling, fordi testbiblioteket i praksis også brukes til innledende kartlegging av symptomtrykk. Betydningen av dette for klassifiseringen drøftes i punkt 4.

3. Rettslig grunnlag

3.1 Kvalifisering som medisinsk utstyr (MDSW)

Etter MDR artikkel 2(1) er «medisinsk utstyr» blant annet programvare som av produsenten er tiltenkt brukt, alene eller i kombinasjon, for formål som «diagnose, forebygging, overvåking, prediksjon, prognose, behandling eller lindring av sykdom». MDCG 2019-11 Rev.1 sin beslutningsmodell for kvalifisering (figur 1, beslutningssteg 1–5) krever at programvaren (i) er «software» etter definisjonen, (ii) ikke utelukkende styrer/påvirker bruken av annet utstyr, (iii) gjør noe mer med data enn lagring, arkivering, kommunikasjon eller enkelt søk, og (iv) er til fordel for den enkelte pasient.

TestBase sin skåringsfunksjon oppfyller alle fire vilkår: den beregner en pasientspesifikk skåre etter en fastsatt algoritme (mer enn enkelt søk, jf. beslutningssteg 3), og gjør dette for den enkelte pasient, ikke for aggregerte/generiske formål (beslutningssteg 4). Dette er for øvrig direkte parallelt til MDCG sin «Manual on borderline and classification» (versjon 5, april 2026), punkt 1.1.9.2 «Medical calculators», som konkluderer at beregning av en skåre «according to a specific formula» basert på publiserte formler/tabeller til fordel for den enkelte pasient oppfyller definisjonen av medisinsk utstyr, og at «classification rule 11 applies […] and classifies this product as at least class IIa». (Manual on borderline and classification, v.5, april 2026, punkt 1.1.9.2, «Outcome»)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har i sitt veiledningssvar av 15. oktober 2026 lagt til grunn samme konklusjon konkret for TestBase: at mekanisk, forhåndsdefinert beregning av en pasientspesifikk skåre ikke endrer at «programvaren utfører en handling på data» utover enkelt søk, og at dette kan oppfylle medisinsk formål etter MDR artikkel 2 nr. 1 dersom skåren er «beregnet på å støtte f.eks. vurdering av depressive symptomer, sykdommens alvorlighetsgrad eller utvikling under behandling». (DMP, e-post 15.10.2026, avsnitt «Deres spørsmål»)

Kvalifisering som MDSW legges etter dette til grunn som avklart, og er ikke gjenstand for videre drøftelse i dette dokumentet. Dokumentets formål er å fastsette riktig *klasse* innenfor dette.

3.2 Klassifiseringsregelverket — regel 11

Etter MDR artikkel 51 og vedlegg VIII klassifiseres medisinsk utstyr i klasse I, IIa, IIb eller III. For programvare er det særlig regel 11 i vedlegg VIII, kapittel III, som er relevant. Regelen lyder i sin helhet (gjengitt i MDCG 2019-11 Rev.1, punkt 4.2.1):

> *«Software intended to provide information which is used to take decisions with diagnosis or therapeutic purposes is classified as class IIa, except if such decisions have an impact that may cause: death or an irreversible deterioration of a person's state of health, in which case it is in class III; or a serious deterioration of a person's state of health or a surgical intervention, in which case it is classified as class*

> *IIb. Software intended to monitor physiological processes is classified as class IIa, except if it is intended for monitoring of vital physiological parameters, where the nature of variations of those parameters is such that it could result in immediate danger to the patient, in which case it is classified as class IIb. All other software is classified as class I.»*
>
> MDR (EU) 2017/745, vedlegg VIII, kapittel III, regel 11 — gjengitt i MDCG 2019-11 Rev.1 (juni 2025), s. 17

MDCG 2019-11 Rev.1 deler regelen i tre underregler: 11a (informasjon til diagnostiske/terapeutiske beslutninger — standardklasse IIa, med opptrapping til IIb/III), 11b (overvåking av fysiologiske prosesser) og 11c (alt annet — klasse I). TestBase sin skåringsfunksjon faller klart under 11a, ettersom den ikke overvåker fysiologiske prosesser (11b er derfor ikke relevant), og den klart er mer enn «alt annet» (11c).

Hvilken klasse som gjelder innenfor 11a avgjøres av en kombinasjon av to forhold, slik MDCG 2019-11 Rev.1 presiserer med henvisning til IMDRF sitt internasjonale rammeverk for risikoklassifisering av SaMD: (A) *betydningen* av informasjonen programvaren gir for helsebeslutningen («behandle/diagnostisere», «driver klinisk oppfølging» eller «informerer klinisk oppfølging»), og (B) *alvorlighetsgraden* av pasientens helsetilstand/-situasjon («kritisk», «alvorlig» eller «ikke-alvorlig»). Sammenhengen er oppsummert i en tabell i MDCG 2019-11 Rev.1 vedlegg III, gjengitt under:

	Høy betydning («behandle/diagnostisere»)	Middels betydning («driver klinisk oppfølging»)	Lav betydning («informerer klinisk oppfølging»)
Kritisk tilstand	Klasse III	Klasse IIb	Klasse IIa
Alvorlig tilstand	**Klasse IIb**	Klasse IIa	Klasse IIa
Ikke-alvorlig tilstand	Klasse IIa	Klasse IIa	Klasse IIa

Tabell 1 (forenklet gjengivelse av MDCG 2019-11 Rev.1, vedlegg III, «Usability of the IMDRF risk classification framework in the context of the MDR»). Tabellen omfatter ikke klasse I, som kun følger av underregel 11c.

Videre følger det av implementeringsregel 3.5 i vedlegg VIII at «if several rules, or if, within the same rule, several sub-rules, apply to the same device based on the device's intended purpose, the strictest rule and sub-rule resulting in higher classification will apply» (MDR vedlegg VIII, implementeringsregel 3.5, gjengitt i MDCG 2019-11 Rev.1, punkt 4.1). Dette har direkte betydning for TestBase, se punkt 4.3, ettersom testbiblioteket dekker flere ulike bruksformål som i prinsippet kunne vurderes hver for seg.

4. Klassifiseringsvurdering

TestBase sin skåringsfunksjon vurderes i det følgende opp mot hver av de tre aktuelle klassene under regel 11a: klasse III, klasse IIa og klasse IIb. For hver klasse presenteres argumenter for og argumenter imot, før en samlet konklusjon trekkes i punkt 4.4.

4.1 Vurdering opp mot klasse III

Klasse III under regel 11 kan utløses på to ulike grunnlag: (i) regel 11a sitt unntak for beslutninger som «may cause death or an irreversible deterioration of a person's state of health», eller (ii) regel 22, som gjelder aktive terapeutiske utstyr «with an integrated or incorporated diagnostic function which

significantly determines the patient management by the device» — typisk lukkede («closed loop») systemer der programvaren selv justerer behandling basert på egen diagnostisk tilbakemelding, uten en uavhengig klinisk beslutning imellom.

ARGUMENTER FOR KLASSE III

- Flere av instrumentene i TestBase sitt bibliotek (eksempelvis traume- og depresjonsrelaterte instrumenter) måler symptomer knyttet til tilstander som i verste fall kan ha svært alvorlige konsekvenser for pasienten, herunder økt selvmordsrisiko — altså et forhold som i prinsippet kunne tale for at «feil» informasjon fra systemet har et forhøyet skadepotensial.
- MDCG 2019-11 Rev.1 sitt eget eksempel om kognitiv terapiprogramvare som «adapts treatment of depression based on diagnostic feedback» plasseres i klasse III under regel 22 — det vil si at programvare som opererer innenfor nøyaktig samme kliniske felt som TestBase (depresjon), kan ende i klasse III dersom funksjonaliteten er utformet annerledes enn i TestBase.

ARGUMENTER MOT KLASSE III

- TestBase har ingen lukket løkke: systemet beregner og presenterer en skåre, men verken velger, justerer eller igangsetter behandling. Enhver klinisk beslutning tas selvstendig av en autorisert behandler. Dette er nøyaktig det forholdet MDCG 2019-11 Rev.1 selv fremhever som avgjørende i sitt eget depresjons-/kognitiv terapi-eksempel: «When a specialist determines the necessary cognitive therapy based on the outcome provided by the MDSW, the MDSW would be classified as class IIa per Rule 11(a)» — altså at nettopp fravær av en lukket løkke tar produktet ut av regel 22 og klasse III. (MDCG 2019-11 Rev.1, vedlegg IV)
- Regel 11a sitt eget unntak til klasse III («death or an irreversible deterioration») er forbeholdt informasjon der en feilaktig beslutning har et *direkte* og svært alvorlig utfall — typisk akutte, kritiske tilstander (jf. MDCG sitt eksempel om bildeanalyse for behandlingsbeslutninger ved akutt hjerneslag, som er klasse III). TestBase sin skåre er ett av flere elementer en behandler vurderer over tid i en ordinær, ikke-akutt klinisk oppfølging, og verken instrumentene i biblioteket eller bruksmønsteret er innrettet mot akutte, kritiske beslutningssituasjoner.
- Produktbeskrivelsen og det foreslåtte tiltenkte formålet i punkt 2 begrenser eksplisitt programvarens rolle til beslutningsstøtte, og utelukker at programvaren selv fastsetter diagnose eller behandling.

DELKONKLUSJON

TestBase sin skåringsfunksjon oppfyller ikke vilkårene for klasse III. Det foreligger ingen lukket løkke (regel 22), og skåren brukes ikke til beslutninger med et direkte, kritisk utfall av den typen regel 11a sitt øverste unntak sikter til.

4.2 Vurdering opp mot klasse IIa

ARGUMENTER FOR KLASSE IIA

- Deler av testbiblioteket brukes til å følge utvikling hos en pasient som allerede er under behandling («utvikling over tid»), ikke til å etablere eller bekrefte en tilstand. Dette ligner det forholdet MDCG 2019-11 Rev.1 selv klassifiserer som IIa i sitt kognitiv terapi-eksempel, der informasjonen «drives

clinical management» (middels betydning) heller enn «diagnosis» (høy betydning) — som for en «alvorlig» tilstand gir klasse IIa, jf. matrisen i punkt 3.2.

- For instrumenter som måler bredere, ikke-kliniske forhold (for eksempel generell livskvalitet/ trivsel, uten en underliggende klinisk alvorlig tilstand), vil selv «diagnose»-betydning kombinert med en «ikke-alvorlig» tilstand gi klasse IIa, jf. matrisens nederste rad.
- Dette samsvarer med gulvet som følger av «Medical calculators»-eksempelet i MDCG sin Borderline- manual: beregning av en pasientspesifikk skåre til fordel for den enkelte pasient «classifies this product as at least class IIa» — altså at IIa under enhver omstendighet er korrekt minimumsklasse. (Manual on borderline and classification, v.5, april 2026, punkt 1.1.9.2)

ARGUMENTER IMOT AT IIA ER TILSTREKKELIG FOR PRODUKTET SOM HELHET

- Testbiblioteket inkluderer, som beskrevet i punkt 2, instrumenter som brukes nettopp til *innledende kartlegging* av om en pasient har symptomer forenlig med en klinisk relevant, alvorlig tilstand (eksempelvis traume- eller depresjonssymptomer). Dette er presist den bruken MDCG 2019-11 Rev.1 sitt eget vedlegg IV-eksempel omtaler som «diagnosis»-betydning (høy), ikke «drives/ informs clinical management» — se nærmere drøftelse i punkt 4.3.
- At programvaren ikke selv fastsetter en formell diagnose, er — som vist i punkt 4.3 — ikke i seg selv tilstrekkelig til å redusere betydningen fra «diagnose» til «driver/informerer klinisk oppfølging». MDCG sitt eget eksempel på nøyaktig denne produkttypen («scoring depression based on inputted data on a patient's symptoms») er selv en ren skåringsfunksjon uten egen diagnosefastsettelse, og klassifiseres likevel med «diagnose»-betydning.
- Implementeringsregel 3.5 krever at den strengeste relevante regelen/underregelen legges til grunn når flere bruksformål er aktuelle for samme produkt, med mindre de ulike bruksformålene er klart avgrenset og dokumentert som separate moduler med hvert sitt tiltenkte formål (jf. MDCG 2019-11 Rev.1 punkt 7 om modulær MDSW). En slik modulavgrensning er ikke gjennomført eller dokumentert for TestBase per i dag — se punkt 5. Inntil dette er gjort, kan ikke IIa legges til grunn for produktet som helhet alene fordi *enkelte* bruksområder isolert sett ville kunne forsvare IIa.

DELKONKLUSJON

Klasse IIa er korrekt *minimumsklasse* og vil være riktig endelig klasse for enkelte, klart avgrensede bruksområder/instrumenter dersom dette dokumenteres som egne moduler i fremtiden. Den er imidlertid ikke tilstrekkelig som klassifisering for TestBase sin skåringsfunksjon slik den er beskrevet og markedsført som ett samlet produkt i dag, fordi testbiblioteket også dekker bruk som etter gjeldende presedens har «diagnose»-betydning for en alvorlig tilstand.

4.3 Vurdering opp mot klasse IIb

ARGUMENTER FOR KLASSE IIB

- MDCG 2019-11 Rev.1 sitt vedlegg IV inneholder et eksempel som ligger svært tett opptil TestBase sin faktiske funksjonalitet: «Diagnostic MDSW intended for scoring depression based on inputted data on a patient's symptoms (e.g. mood, anxiety) should be classified as class IIb under Rule 11(a) [...] as the healthcare situation (depression) is serious and the significance of the information is

'diagnosis'». (MDCG 2019-11 Rev.1, vedlegg IV) Dette eksempelet beskriver nøyaktig en ren skåringsfunksjon basert på pasientrapporterte symptomer, uten at programvaren selv fastsetter diagnosen — presist TestBase sin arbeidsmåte.

- TestBase sitt testbibliotek dekker instrumenter rettet mot tilstander som alminnelig anses «alvorlige» i IMDRF/MDCG sin forstand (traumer, depresjon), og brukes blant annet til innledende kartlegging av symptomtrykk — det vil si «diagnose»-betydning for en alvorlig tilstand, som etter matrisen i punkt 3.2 gir klasse IIb.
- Ettersom TestBase per i dag markedsføres og driftes som ett samlet produkt uten dokumentert modulavgrensning mellom «kartleggings»- og «oppfølgings»-bruk, følger det av implementeringsregel 3.5 at den strengeste relevante klassifiseringen skal legges til grunn for produktet som helhet. Siden minst én reell, udiskutabel bruk av biblioteket (symptomkartlegging av en alvorlig tilstand) etter presedens gir IIb, må IIb legges til grunn inntil en eventuell fremtidig modulavgrensning er gjennomført og dokumentert.

ARGUMENTER SOM KUNNE TALE FOR LAVERE KLASSE, OG HVORFOR DE IKKE ER AVGJØRENDE

- *«Programvaren stiller ikke selv en diagnose, kun en statistisk skåre/sannsynlighet.»* — Dette er korrekt beskrivelse av TestBase, men det er ikke et forhold som skiller TestBase fra presedensen: MDCG sitt eget IIb-eksempel beskriver nettopp en ren skåringsfunksjon uten egen diagnosefastsettelse. Argumentet reduserer dermed ikke klassen.
- *«Mange av testene brukes til oppfølging av pågående behandling, ikke til ny kartlegging.»* — Dette er riktig og reelt, og er nøyaktig grunnen til at enkelte, klart avgrensede bruksområder kan forsvare IIa i fremtiden (jf. punkt 4.2). Det er imidlertid ikke tilstrekkelig til å senke klassen for *hele* produktet i dag, fordi den aktuelle avgrensningen mellom bruksområdene ikke er gjennomført og dokumentert som egne moduler. Dette er et forbedringspunkt for fremtidig arbeid (se punkt 5), ikke et argument for lavere klasse nå.
- *«En autorisert behandler er alltid involvert og tar den endelige beslutningen.»* — Dette er riktig, og er nettopp grunnen til at klasse III er utelukket (se punkt 4.1). Det er imidlertid ikke avgjørende for skillet mellom IIa og IIb: regel 11a sitt skille mellom disse to klassene er knyttet til alvorlighetsgrad og informasjonens betydning, ikke til om en kliniker er involvert i den etterfølgende beslutningen. Kun unntaket til klasse III (via regel 22, lukket løkke) er direkte betinget av fravær av en slik uavhengig klinisk beslutning.

KONKLUSJON — PUNKT 4.3

Ingen av innvendingene mot klasse IIb er egnet til å redusere klassifiseringen til IIa for produktet som helhet, slik det er beskrevet og markedsført i dag. Klasse IIb legges derfor til grunn.

4.4 Samlet konklusjon

SAMLET KONKLUSJON

TestBase sin skåringsfunksjon for psykologiske selvrapporteringstester kvalifiserer til ikke å være klasse III (ingen lukket løkke, ingen direkte kritisk beslutningsvirkning), og klasse IIa er

ikke tilstrekkelig for produktet som helhet slik det i dag er beskrevet og driftet som ett samlet produkt, fordi testbiblioteket omfatter bruk — symptomkartlegging av alvorlige psykiske tilstander — som etter gjeldende offisiell presedens (MDCG 2019-11 Rev.1, vedlegg IV) har «diagnose»-betydning for en «alvorlig» tilstand. Dette gir, etter regel 11a i MDR vedlegg VIII og implementeringsregel 3.5, **klasse IIb** som riktig risikoklasse for TestBase sin skåringsfunksjonalitet, slik den er beskrevet i punkt 2.

5. Forbehold, åpne punkter og videre arbeid

Følgende forhold bør merkes ved videre bruk av denne vurderingen:

- Dette er produsentens egen vurdering, i tråd med MDR sitt prinsipp om at produsenten selv er ansvarlig for kvalifisering og klassifisering (jf. DMP sitt veiledningssvar av 15.10.2026). Vurderingen er ikke kvalitetssikret av et meldt organ eller en ekstern regulatorisk rådgiver, og bør gjennomgås av en slik part før den legges til grunn i den formelle tekniske dokumentasjonsfilen.
- En fremtidig, dokumentert avgrensning av testbiblioteket i separate moduler med hvert sitt presist formulerte tiltenkte formål (jf. MDCG 2019-11 Rev.1 punkt 7) kan gi grunnlag for at enkelte, rendyrkede oppfølgings- eller lavrisikoinstrumenter klassifiseres som IIa separat fra resten av biblioteket. Dette er ikke gjort i denne vurderingen, og er et mulig fremtidig forbedringstiltak dersom lavere klasse er ønskelig for deler av produktet.
- Et kjent, ikke utbedret funn i den tekniske dokumentasjonen (se prosjektets CLAUDE.md og beslutningslogg) er at enkelte skåringsberegnere (blant annet for ITQ og et PHQ-9-aktig instrument) bruker posisjonsbasert svarindeksering, slik at en pasient som hopper over ett ledd kan få en stille feilberegnet skåre. Dette er nøyaktig den typen forhold som må identifiseres og utbedres gjennom risikostyring etter NS-EN ISO 14971 før en teknisk dokumentasjonsfil kan anses komplett for en klasse IIb-enhet, og bør prioriteres i forkant av et designfrys for CE-merking.
- Vurderingen må oppdateres dersom det tiltenkte formålet eller funksjonaliteten endres vesentlig, jf. MDCG 2019-11 Rev.1 punkt 8 om endringer i MDSW.

6. Kildehenvisninger

1. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr («MDR»), særlig artikkel 2(1), artikkel 51 og vedlegg VIII (klassifiseringsregler, herunder regel 11 og implementeringsregel 3.5).
2. Medical Device Coordination Group, *MDCG 2019-11 Rev.1 — Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745 (MDR) and Regulation (EU) 2017/746 (IVDR)*, oktober 2019 / revidert juni 2025. Særlig punkt 3–4.2.1 (kvalifisering og regel 11), vedlegg III (IMDRF- matrise) og vedlegg IV (klassifiseringseksempler, herunder eksemplene om skåring av depresjon og kognitiv terapiprogramvare).
3. Medical Device Coordination Group / Borderline and Classification Working Group, *Manual on borderline and classification for medical devices under Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746*, versjon 5, april 2026. Særlig punkt 1.1.9.2 «Medical calculators».
4. Direktoratet for medisinske produkter (DMP), e-post «Forespørsel om veiledning — kvalifisering av programvare for skåring av psykologiske selvrapporteringstester», 15. oktober 2026 (se `docs/kvalifisering av programvare for skåring av psykologiske selvrapporteringstester.pdf` i dette repositoriet).
5. EFPIA, *Position on Medical Calculator Qualification/Classification*, september 2024, v5.0 — vurdert og funnet ikke å endre konklusjonen, se drøftelse i samtale forut for dette dokumentet (industriens foreslåtte unntak for «enkle» kalkulatorer omfatter ikke flerledds skåringsinstrumenter av TestBase sin type).